

# Midazolam en soins palliatifs

Anxiolyse · prescription anticipée · sédation proportionnée · SPCMD — qui fait quoi, quand, comment  
Adulte en ESMS (EHPAD, USLD, MAS, FAM, EAM) — repères pour les médecins DOTR en téléconsultation



## Midazolam = 1<sup>re</sup> intention

Molécule de référence des pratiques sédatives. **Voie SC prévue par le RCP** si pas d'abord veineux.



## Diazépam SC : non

Voie **hors RCP** (IM, IV lente, intrarectal) et **déconseillée par la HAS** ; demi-vie longue, accumulation.



## SPCMD : jamais à distance

Décision **collégiale** ; le **médecin est présent** à l'initiation. Ne s'initie pas en téléconsultation.

## Quelle situation ? Arbre décisionnel

Résident en situation palliative : anxiété, agitation, dyspnée, douleur ou détresse mal soulagée → chercher une cause (douleur, fécalome, globe, hypoxie, iatrogénie, sevrage), accompagner, directives anticipées, personne de confiance



Détresse aiguë ? **Asphyxie, hémorragie grave, détresse respiratoire majeure**

OUI

## B PRESCRIPTION ANTICIPÉE

L'IDE applique la prescription **rédigée à l'avance**, appelle le médecin ou le **15**. Sans prescription : **15**.

NON



Symptôme **réfractaire** ? (tout a été tenté sans soulagement suffisant)

NON

## A ANXIOLYSE — PATIENT VIGILANT

Traiter la cause, accompagner, traitement symptomatique habituel (voie orale si possible). **Pas de pratique sédative**.

OUI



SPCMD envisagée ? Demande du patient (L1110-5-2) ou arrêt d'un traitement de maintien en vie

NON

## C SÉDATION PROPORTIONNÉE

**Midazolam titré**, profondeur et durée **proportionnées au soulagement**, réversible, réévaluée (doses page 2).

OUI

## D SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE MAINTENUE JUSQU'AU DÉCÈS (SPCMD)

Décision **collégiale** · **médecin présent** à l'initiation et jusqu'à stabilisation · IDE et médecin joignables **24 h/24** (EHPAD sans IDE de nuit : **HAD**) · appui d'une **équipe de soins palliatifs** (page 2).

## Évaluer la profondeur — échelle RASS

Sessler 2002, version française Chanques 2006

| +4                                                           | +3         | +2    | +1                    | 0              | -1        | -2                    | -3                                   | -4                              | -5              |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Combatif                                                     | Très agité | Agité | Ne tient pas en place | Éveillé, calme | Somnolent | Contact visuel < 10 s | Bouge à l'appel, sans contact visuel | Bouge à la stimulation physique | Non réveillable |
| Sédation proportionnée : le niveau le plus léger qui soulage |            |       |                       |                |           |                       | SPCMD : -4 / -5                      |                                 |                 |

## À CHAQUE ÉTAPE

**Réévaluer** · **informer** le patient, la personne de confiance, les proches · appeler l'**EMSP** au moindre doute · **tracer** : motif, situation choisie (A à D), prescription, RASS et soulagement, effets indésirables, information donnée ; SPCMD : procédure collégiale et motifs.

Sources : CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD

## Midazolam — repères de dose (HAS 2020)

Demi-vie 1,5 à 2,5 h · voie IV de préférence, SC si pas d'abord veineux (RCP)

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titration IV</b>            | <b>0,5 à 1 mg</b> toutes les <b>2 à 3 min</b> jusqu'au soulagement — sujet âgé, insuffisance d'organe, dénutrition sévère, déshydratation : <b>0,5 mg</b> , intervalle jusqu'à <b>5 min</b> |
| <b>Dose de charge SC</b>       | <b>0,05 à 0,1 mg/kg</b> , à renouveler toutes les <b>20 à 30 min</b> jusqu'au soulagement                                                                                                   |
| <b>Sans titration / charge</b> | Débit continu <b>0,5 à 1 mg/h</b> (IV ou SC), <b>réduit chez le sujet âgé ou fragilisé</b> ; évaluation et adaptation toutes les <b>30 min</b>                                              |
| <b>Entretien</b>               | Débit horaire = <b>50 %</b> de la dose cumulée de titration (SPCMD IV : <b>50 à 100 %</b> )                                                                                                 |
| <b>Secours</b>                 | Bolus = <b>dose reçue en 1 h</b> — IV toutes les 2 à 3 min, SC toutes les 20 à 30 min — <b>prescrits d'avance</b>                                                                           |
| <b>Détresse aiguë (B)</b>      | Après avis d'un médecin expérimenté : charge <b>2 à 5 mg</b> ; sans voie IV, <b>IM plutôt que SC</b> (entretien SC) ; opioïde associé possible                                              |
| <b>2e intention</b>            | Échec du midazolam : <b>neuroleptique</b> (lévomépromazine SC, chlorpromazine IV) sur avis d'un médecin expérimenté, <b>midazolam poursuivi</b> ; jamais 2 benzodiazépines                  |

## D · SPCMD — CADRE LÉGAL

## Quand ? (CSP L1110-5-2)

- **Demande du patient** : affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court terme, souffrance réfractaire — ou arrêt d'un traitement entraînant une souffrance insupportable
- **Patient hors d'état de s'exprimer** : arrêt d'un traitement de maintien en vie (refus de l'obstination déraisonnable)

## Comment ?

- **Procédure collégiale** : médecin consultant sans lien hiérarchique, avis possible à distance ; motifs au dossier
- L'IDE débute « **en présence du médecin** » qui a décidé et prescrit
- Cible **RASS -4/-5** ; évaluation /15 min la 1re heure, puis **≥ 3 fois/jour** en EHPAD
- EHPAD sans IDE de nuit : HAD ; lit de repli prévu

Sources : CSP L1110-5-1, L1110-5-2 · CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD · SFAP 2017 — fiches SPCMD

## LE MÉDECIN DOTR EN TÉLÉCONSULTATION

## Peut

- Évaluer, chercher la cause, traiter le symptôme (A)
- Rédiger la **prescription anticipée (B)** : « Protocole de soins infirmiers sur prescription anticipée » — patient nommé, critères, dose, voie, nombre maximal, surveillance, appel du médecin (proposition DOTR)
- Prescrire une **sédation proportionnée (C)** si IDE 24 h/24, médecin joignable et avis EMSP ; sinon relais EMSP / HAD (proposition DOTR)
- Participer à la **procédure collégiale**, y compris comme consultant à distance (loi 2026 : « le médecin référent en téléconsultation »)

## Ne peut pas

- **Initier une SPCMD à distance**

Sources : CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · Loi n° 2026-404 du 26/05/2026 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD

## MIDAZOLAM INDISPONIBLE — RECOURS PONCTUEL

- **Voie IV** : diazépam **5 mg IV lente** ou clonazépam **0,5 mg IV** — renouvelable 1 fois après 15 min
  - **Sans voie IV** : diazépam **5 mg intrarectal** (renouvelable après 15 min) ou clonazépam **1 mg SC** (après 30 min ; SC hors RCP)
  - Sujet âgé, insuffisance hépatique ou rénale, cachexie : **doses ÷ 2** ; détresse aiguë : doses × 2 possibles (HAS)
- Dépannage, **pas un protocole** au long cours.

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · RCP Rivotril injectable

## PRÉREQUIS ET APPROVISIONNEMENT

- **IDE** pour titrer et surveiller ; SPCMD : IDE et médecin joignables **24 h/24**
- **Équipe de soins palliatifs** (EMSP, HAD) : systématique pour une SPCMD hors hôpital
- Loi 2026 : **volet soins palliatifs** du projet d'établissement, **conventions EMSP**
- Midazolam en **officine** (indication « sédation en soins palliatifs ») : **ordonnance sécurisée, 28 j**, délivrance fractionnée **7 j** — **anticiper la commande**

Sources : HAS 2018/2020 — guide SPCMD · Loi n° 2026-404 du 26/05/2026 · Arrêtés 15/12/2021 et 09/02/2022 · RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL

## VU SUR LE TERRAIN

« **L'IDE refuse le midazolam SC** » → la voie SC est dans le RCP ; une prescription écrite précise (B ou C) et l'appui de l'EMSP lèvent la réticence. « **L'EMSP utilise le diazépam SC /4 h** » → hors RCP, déconseillé par la HAS : en discuter avec elle. « **Pas de midazolam à la pharmacie** » → commande anticipée ; en attendant, recours ponctuel ci-dessus.

Sources : RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL · HAS 2020 — réponse rapide COVID-19

Sources : HAS, pratiques sédatives en situations palliatives (RBP, janv. 2020) ; HAS, guide SPCMD (2018, actualisé 2020) ; HAS, réponse rapide COVID-19 épargne du midazolam (avr. 2020) ; SFAP (2009, 2017, mémo midazolam en ville 2021) ; RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL (2024), Valium injectable (2024), Rivotril injectable ; arrêtés 15/12/2021 et 09/02/2022 ; CSP L1110-5-1, L1110-5-2, R4127-37-2 et 37-3 ; loi n° 2026-404 du 26/05/2026 (art. 11, 12, 19) ; RASS (Sessler 2002 ; Chanques 2006). Non trouvé dans ces sources : un schéma de midazolam « anxiolytique » ; une conduite propre (seuil respiratoire, flumazénil) aux pratiques sédatives palliatives — à arbitrer avec l'EMSP.

Repères pratiques : ne remplacent ni l'évaluation clinique, ni l'avis de l'équipe de soins palliatifs, ni le protocole de l'établissement.

Proposition DOTR = choix d'organisation, non issu d'un texte.